



FICHA DE INGRESO PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL

Conforme a normativa chilena – Uso Clínico

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

- Nombre: Gonzalo Osorio García
- RUN: 24.616.389-8
- Fecha de nacimiento: 09-05-2014
- Edad: 11 años
- Sexo: masculino
- Escolaridad: 6° a 7° en escuela especial
- Establecimiento educacional: Colegio diferencial Quillahue
- Nombre del cuidador/tutor legal: Sebastian Osorio
- Contacto: sebastiano.sandoval@gmail.com

2. MOTIVO DE CONSULTA

- Descripción del motivo de consulta: padre refiere necesidad de acreditar diagnóstico debido a que requiere gestionar credencial de discapacidad
- Tiempo de evolución: Con diagnóstico de TEA desde etapa preescolar, habría sido realizado por neurologo, ADOS-2 realizado sugerente de TEA,, padre refiere que habría estado con diferentes neurólogos y psiquiatras. Padre refiere habría sido tratado con ayzmol, aradix y luego con neoradix, le producen irritabilidad, neurólogo indica suspender. Estuvo además con psiquiatra quien habría indicado ácido valproico 400 mg cada 12 hrs, con lo cual no observa buena respuesta, lo suspenden. Padre describe un funcionamiento actual con dificultades principalmente en escuela, en donde no logra permanecer mucho tiempo en sala, requiere pausas cada 20-30 min, se sale de sala, en colegio dice garabatos, le ha pegado a otros niños, ha roto cosas. A pesar de esto padre refiere que desregulaciones han disminuido en el tiempo, en casa logran regulación, en colegio son las mayores dificultades. Fallece madre 2024, estuvo con psicólogo, algunas noches aun llora pero padre y abuela paterna lo contienen, lloran juntos. Abuela decide irse a vivir con ellos por ausencia de madre, refiere esta es su figura materna, buen vínculo afectivo. De ánimo padre lo ve bien, no ha manifestado ideas de no querer vivir más. Conductas de autodaño cuando era pequeño, ya no. Pasa gran parte del día en pantallas, tiene jornada hasta las 12.00 pero padre desea aumentarla hasta las 13-14 porque en casa pasa mucho tiempo en pantallas. No le gusta salir, a nivel social interactúa con primos, en colegio no manifiesta amistades. Selectividad alimentaria presente: sushi y carne.

- A entrevista con Gonzalo: cooperador, pueril, distractil, refiere vivir con padre y abuela materna, intereses menciona videojuegos, no menciona otros. Dice sentirse querido por su familia, niega conflictos a nivel familiar, se indaga en animo, refiere que esta bien, nega pena. Con respecto a colegio refiere no le gusta por los gritos de los otros niños, prefiere colegio anterior, desea volver a ese. Ganas de vivir: bien.
- Sueño: se acuesta a las 8.00, logra conciliar sueño rápido, padre le da melatonina, duerme sin interrupciones.

3. ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS PERSONALES

- Diagnósticos previos: diagnóstico de TEA desde etapa preescolar, luego se habria indicado además dg de TDAH, habria sido realizado por neurologo, padre refiere que habria estado con diferentes neurologos y psiquiatras
- Hospitalizaciones previas: de salud mental no
- Tratamientos farmacológicos: estuvo en tratamiento con azymol y aradix y luego neoaradix, padre describe que con este “se alteraba”, irritabilidad, junto con neurólogo deciden suspenderlo.
- Psicoterapia previa: si, en psicoeduka y previas
- Conductas autolesivas / ideación suicida: no, antes autodaño, ya no presente, sin ideación suicida

4. ANTECEDENTES MÉDICOS GENERALES

- Patologías médicas relevantes: usuario lentes ópticos, padre no sabe diagnóstico, sin otros antecedente médicos entregados. 54kg
- Tratamientos actuales: melatonina 3 mg una por noche
- Alergias: niega
- Cirugías: no

5. ANTECEDENTES FAMILIARES

- Antecedentes psiquiátricos familiares:
- Contexto psicosocial relevante: Gonzalo vive actualmente junto a su padre y abuela materna en Santiago, esta última se va a vivir con ellos tiempo después que la madre de Gonzalo falleciera de pancreatitis el año 2024 (muerte inesperada).

6. EVALUACIÓN DEL ESTADO MENTAL

- Apariencia: constitución mesomorfa, impresiona menor a edad cronológica, vestimenta e higiene adecuada
- Actitud: cooperador, distractil, pueril para edad
- Psicomotricidad: se observa aumentada, separa varias veces de su puesto mientras se realiza entrevista a padre
- Lenguaje: Notificativo, atingente, sin alteraciones en estructura.
- Pensamiento: Sin alteraciones formales, niega delirios y niega alteraciones sensoriales hoy. Logra dar cuenta de que no le gusta su colegio actual, prefería el anterior, habla de sus intereses, menciona solo videojuegos.
- Ánimo impresiona eutímico
- Contacto visual corto
- Juicio de realidad: conservado, no psicótico.
- Insight: no

7. EVALUACIÓN DE RIESGO

- Riesgo suicida: no
- Factores de riesgo: TEA y TDAH de base, dificultades sensoriales presentes, presencia de desregulaciones frecuentes, duelo materno, funcionamiento intelectual limítrofe.
- Factores protectores: red de apoyo padre y abuela paterna, padre lo lleva a los psicólogo, to, neurólogo y psiquiatra, adhiere, se moviliza. Se describe vínculo materno con abuela, quien le entrega afecto igual que el padre. Padre con jornada laboral hasta las 16.30-15.30, en la semana puede estar con él.

:

8. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA (DSM-5 / CIE-11)

- Diagnóstico principal: TEA-TDAH
- Diagnósticos secundarios: FIL-duelo madre

9. PLAN TERAPÉUTICO

- Tratamiento farmacológico: azymol 5 mg 1 al día para apoyo en tendencia a desregulación emocional, si presenta RAM irritabilidad suspender
- Intervenciones psicosociales:
 - pasar tiempo libre fuera de pantallas junto a padre, realizar actividades juntos
 - pantallas no mas 2 hrs al día, de manera sana en tiempo y contenido
 - higiene del sueño: sin pantallas 2 hrs antes de acostarse-
 - fomentar actividades en familia, rituales familiares (padre planea salir a jugar tenis con él).
 - mantener comunicación de padre con colegio
 - uso de audífonos canceladores de ruido en colegio (Gonzalo menciona molestia por ruidos de otros niños en colegio)
- Derivaciones:mantener psicólogo y TO, padre además lo apoyará con profesor diferencial para poder reinsertarse en colegio convencional
- Otros: se envía informe biomédico y archivo adjunto completado se agrega a diagnósticos FIL, WISC vigente diciembre 2025, CI total 75

10. SEGUIMIENTO

- Fecha próximo control: 2 meses o SOS (si aumenta frecuencia o intensidad de desregulaciones)
- Red de apoyo:padre y abuela paterna
- Indicaciones a cuidadores: fomentar actividades con familia, disminuir hrs de pantallas

11. DATOS DEL PROFESIONAL

Nombre: Caterina Schiappacasse Arteaga

Especialidad:psiquiatra infanto juvenil

Registro profesional:105595

Centro de atención: Psicoeduka Santiago

Fecha: 29 abril de 2026